



GUIA GRATUITO · WEBINÁRIO ITH

Protocolo de sepse: da triagem ao pacote da primeira hora

Por que o tempo importa, os erros que atrasam o tratamento, indicadores calculados e uma ficha de abertura do protocolo.

WEBINÁRIO COM

Esp. Juliana Dias

Embaixadora do MBA em SCIRAS e Segurança do Paciente



POR QUE O TEMPO IMPORTA

Na sepse, o atraso é o principal erro

Sepse é a disfunção orgânica ameaçadora à vida causada por uma resposta desregulada a uma infecção (Sepsis-3). Em pacientes com choque séptico, cada hora de atraso no antimicrobiano adequado foi associada a aumento da mortalidade em estudos clássicos. Por isso o protocolo existe: tirar a decisão do "vamos observar" e colocar um relógio rodando.

Sinais de alerta

Infecção suspeita ou confirmada com:

- ☐ Temperatura > 37,8 °C ou < 35 °C
- ☐ FC > 90 bpm · FR > 20 irpm
- ☐ Leucócitos > 12.000 ou < 4.000/mm³ ou > 10% de formas jovens

Disfunção orgânica

- ☐ PAS < 90 ou PAM < 65 mmHg
- ☐ SpO₂ < 90% ou necessidade de O₂
- ☐ Rebaixamento de consciência, agitação ou delirium
- ☐ Diurese < 0,5 mL/kg/h · lactato elevado
- ☐ Plaquetas < 100.000 · creatinina ou bilirrubina > 2 mg/dL

CASO ILUSTRATIVO · SITUAÇÃO COMPOSTA A PARTIR DE OCORRÊNCIAS COMUNS, COM DADOS FICTÍCIOS

"Agitação" às 22h, protocolo às 3h

Paciente de 74 anos internado por pneumonia. Às 22h, FR 26, FC 114 e confusão mental. A equipe interpreta como "agitação noturna" e administra sedativo. Às 3h, PA 82 × 46 mmHg; o protocolo é aberto e o antibiótico corre às 4h10. O paciente vai para a UTI em choque séptico.

O que falhou: a confusão mental era disfunção orgânica e não foi reconhecida como tal (furo 1); a triagem de sepse só era feita na admissão, não nas reavaliações (furo 2); e não havia critério escrito que obrigasse a abrir o protocolo diante de FR e FC alteradas com infecção conhecida (furo 3). O tempo zero real era 22h.

TRATAR

Pacote da primeira hora: o quê e por quê

Item	O que fazer	Por quê
Lactato	Coletar; se elevado, repetir para acompanhar	Marca hipoperfusão antes de a pressão cair e mostra se o tratamento está funcionando
Hemoculturas	Coletar antes do antibiótico, sem atrasá-lo	Depois da 1ª dose a chance de isolar o agente cai muito, e é a cultura que permite ajustar o tratamento
Antimicrobiano	Ampla espectro, conforme protocolo e perfil local	É a única medida que trata a causa; o atraso é o que mais se associa a pior desfecho
Volume	Cristaloide 30 mL/kg se hipotensão ou lactato ≥ 4 mmol/L, com reavaliação	Restaura o volume circulante; reavaliar evita sobrecarga em cardiopatas e renais
Vasopressor	Se a hipotensão persistir, para PAM ≥ 65 mmHg	Mantém a perfusão dos órgãos enquanto o antibiótico age

ERROS MAIS COMUNS DA EQUIPE

- ☐ Registrar como tempo zero o horário da prescrição, e não o do reconhecimento
- ☐ Esperar o resultado do lactato para começar o volume
- ☐ Usar qSOFA isolado como triagem (não recomendado pela SSC 2021)
- ☐ Antibiótico prescrito às 14h e administrado às 16h porque "estava na farmácia"
- ☐ Triar sepse só na admissão, e não a cada reavaliação
- ☐ Não reavaliar perfusão e diurese depois do volume

CÁLCULO RESOLVIDO

Auditoria de 40 protocolos do trimestre

Antibiótico em até 60 min = $26 \div 40 \times 100 = 65\%$

Hemocultura antes do antibiótico = $34 \div 40 \times 100 = 85\%$

Adesão ao pacote completo (todos os itens no prazo) = $22 \div 40 \times 100 = 55\%$

Leitura: o pacote completo é o indicador mais exigente, porque um item atrasado derruba o caso inteiro. Olhe item por item para descobrir qual etapa puxa o resultado para baixo (aqui, o antibiótico).

FERRAMENTA PARA IMPRIMIR

Ficha de triagem e abertura do protocolo de sepse

Paciente: _____ Prontuário: _____ Setor/leito: _____

Data: _____

1. Triagem (enfermagem)	Sim
Infecção suspeita ou confirmada	☐
Temperatura > 37,8 °C ou < 35 °C	☐
FC > 90 bpm	☐
FR > 20 irpm	☐
Algum sinal de disfunção orgânica (PA, SpO ₂ , consciência, diurese)	☐

2. Abertura e pacote	Horário	Responsável
Tempo zero (reconhecimento)		
Médico acionado		
Lactato coletado		
Hemoculturas coletadas (2 amostras)		
1ª dose do antimicrobiano administrada		
Volume iniciado (se indicado)		
Vasopressor iniciado (se indicado)		
Reavaliação de perfusão / 2º lactato		

Sepse descartada pelo médico? () Sim · Motivo: _____ · Assinatura: _____



PRÓXIMO PASSO

Quer aprofundar este tema ao vivo?

Este guia resume os pontos centrais. No webinar gratuito com a Esp. Juliana Dias, você vê os exemplos da rotina e tira suas dúvidas no chat.

Webinário gratuito: Protocolo de sepse

Online e ao vivo. Inscreva-se e receba a data e o link no WhatsApp e no e-mail.

Quero me inscrever grátis

mkt.faculdadeith.com.br/lp/webinario-protocolo-sepse/

MBA em SCIRAS e Segurança do Paciente · 100% EAD

Controle de infecção, gestão de riscos, acreditação e núcleo de segurança do paciente. 440 horas, diploma reconhecido pelo MEC (ITH, conceito 5).

Conhecer o MBA

Fontes

- Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2021.
- Singer M. et al. Sepsis-3, JAMA 2016.
- Kumar A. et al. Duration of hypotension before initiation of effective antimicrobial therapy is the critical determinant of survival in human septic shock. Crit Care Med, 2006.
- Instituto Latino-Americano de Sepse (ILAS). Roteiro de implementação de protocolo gerenciado de sepse.